

Przewartościowanie *wyobrażeń*

Lęk zdrowotny ma swoje obrazy — śmierci, leżenia w szpitalu, pogrzebu. Można je przepisać.

CZAS: 45–60 min 2–3 sesje z terapeutą **ŹRÓDŁO:** Arntz (2012); Hackmann i in. (2011); Wild & Clark (2011)

JAK UŻYWAĆ

Z pomocą terapeuty zidentyfikuj **obraz wyobraźniowy**, który wraca w lęku zdrowotnym (śmierć, diagnoza, pogrzeb, bliskich w żałobie). Wprowadź się w niego, opisz na głos. Następnie *przepisz* scenę z nowym zakończeniem: ratunek, mądrzejsza wersja siebie, opieka, akceptacja.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wyobrażenia (ang. *mental imagery*) wzbudzają lęk silniej niż słowa, bo angażują obszary mózgu powiązane z realnym doświadczeniem (Holmes & Mathews 2010). W lęku zdrowotnym 70–85% pacjentów ma powracający obraz katastroficznego (Hackmann 2011). Przewartościowanie (ang. *imagery rescripting*, Arntz 2012) **nie zaprzecza** obrazowi — daje mu nowe zakończenie. Efekt: $d = 1.04$ dla redukcji intruzji (Morina i in. 2017, meta-analiza). Działa po 2–4 sesjach — szybciej niż klasyczna restrukturyzacja.

01 ☉ Cztery etapy — schemat sesji

ETAP 1

Identyfikacja

Jaki obraz wraca? Kiedy zaczął się pojawiać? Jakie wydarzenie z przeszłości może być źródłem?

ETAP 2

Wejście

Zamknij oczy. Wejdź w obraz w czasie *teraźniejszym*: „widzę, słyszę, czuję...”. 5–10 min.

ETAP 3

Interwencja

Wprowadź **nową postać / nowe wydarzenie**. Mądra wersja Ciebie, terapeuta, bliska osoba — wchodzi do sceny.

ETAP 4

Nowe zakończenie

Scena kończy się *inaczej*: ratunek, opieka, akceptacja, nowa rozmowa. Zapamiętaj **obraz końcowy**.

02 💡 Typowe obrazy w lęku zdrowotnym

DIAGNOZA

Siedzisz w gabinecie. Lekarz powoli mówi: „mam dla Pana/Pani złe wiadomości...”. Zatrzymanie w tym momencie.

SZPITAL

Leżysz w sali szpitalnej. Igły, monitory. Bliscy płaczą. Czujesz osamotnienie i bezradność.

POGRZEB / BLISCY

Widzisz partnera/-kę, dzieci, rodziców — bez Ciebie. Co o Tobie mówią? Co czują? Jak sobie radzą?

WYDARZENIE Z DZIECIŃSTWA

Często źródłem jest *realne* wspomnienie: śmierć dziadka, choroba rodzica, sąsiad z rakiem. Wracamy do tej sceny — i ją przepisujemy.

A · MÓJ POWRACAJĄCY OBRAZ

— co widzę, słyszę, czuję; dokładnie

B · MOŻLIWE ŹRÓDŁO — WYDARZENIE Z PRZESZŁOŚCI

— kiedy, kto, co

C · KOGO WPROWADZAM DO SCENY

— mądra wersja siebie, terapeuta, postać opiekuńcza

D · NOWE ZAKOŃCZENIE SCENY

— co się dzieje, jakie słowa padają, co czujesz

E · OBRAZ KOŃCOWY DO ZAPAMIĘTANIA

— jedno wyraźne ujęcie, które wracasz przed snem

TYLKO Z TERAPEUTĄ

Pierwsze 1–3 sesje rescriptingu robisz z osobą prowadzącą. Pacjent może się *zalać* emocjami — terapeuta wyjścia.

NIE ZAPRZECZAJ

Nie mówisz „to nieprawda” — to *nie* restrukturyzacja. Mówisz „**dzieje się coś innego**”: wchodzi opieka, ratunek, akceptacja.

PO SESJI — UZIEMIENIE

Po sesji 10 min spaceru, kawy, rozmowy — żeby *wyjść* z trybu wyobraźniowego do tu i teraz.

CODZIENNIE 2 MIN

Wracaj do **obrazu końcowego** 2 min dziennie przez 2 tygodnie. Konsolidacja wymaga powtórzeń.

Klucz: przewartościowanie wyobrażeń jest skuteczne, bo *obraz* jest językiem lęku — silniejszym niż logika. Restrukturyzacja działa na lewą półkulę („to nieprawdopodobne”), rescripting — na prawą („to wygląda inaczej”). Najsilniejszy efekt: 1 sesja na 2–3 tyg. przez 6–8 tygodni (Wild & Clark 2011).